LLM 직무 관점 해석 리포트 — 2028 보육·소아의료 급감 위험

개요

2028 예측 결과를 보육정책·보건·예산 담당자 관점으로 LLM에 해석시켰고, 프롬프트를 3회 고쳐(v1→v4) 최종 해석에서 숫자 오류 0건을 만들었다. 모든 숫자는 결과 엑셀과 코드로 대조했고, LLM이 찾아낸 우리 분석의 표시 오류 1건도 입력에 반영했다.

- 입력: 2028 예측 요약(유형별 수, 전국 추세·중앙값, 모델 성능), 위험 상위 20곳과 SHAP 요인 3개, ①·②·③ 전체 지역 목록(0~5세 인구, 어린이집 수, 소아과 의원 수, 위험순위). 약 6천 자.
- LLM: Claude. 버전·관점마다 새 대화에서 프롬프트만 넣고, 웹 검색 없이 답하게 했다. 응답은 고치지 않고 부록에 원문으로 남겼다.
- 검증: 응답의 숫자·지역·개수 주장을 결과 파일(사분면_v4.1, 상위 20 위험이유)과 코드로 대조

버전	호출 수	프롬프트 핵심
v1	1	역할 없이 “해석해줘”
v2	3	역할 부여(보육정책 / 보건소 / 예산)
v3	3	역할의 업무·목표 + 근거 규칙 5개 + 출력 형식
v4	3	v3 응답의 문제를 막는 규칙 3개 추가 + 입력 보완 + 부서 간 충돌 항목

프롬프트 개선 과정

매 버전은 이전 응답에서 발견한 문제를 하나씩 막도록 고쳤다. 검증된 숫자 오류는 v1 1건 → v2 1건 → v3 0건(표현 오해 1건) → v4 0건이다.

버전	바꾼 점	이전 응답에서 발견한 문제	결과
v1 → v2	역할(보육정책·보건소·예산 담당자) 부여	v1은 정책 해석보다 모델 평가·발표 조언에 치우침. “상위 20곳 중 17곳” 오류(실제 18곳)	관점별 업무가 나옴. 하지만 길이 2천~3천 자, 숫자 오류 1건(예산 “17곳”), 입력에 없는 사실(지방소멸대응기금, 2027 본예산 심의 단계)을 표시 없이 씀

버전	바꾼 점	이전 응답에서 발견한 문제	결과
v2 → v3	역할의 하는 일·목표 명시, 규칙 5개(입력 숫자만, 외부 사실은 [추정], 점수≠확률, 유형별 다른 대응, SHAP≠인과), 900자·네 항목 형식	입력 밖 주장이 섞임, 답이 길어 비교가 어려움	숫자 오류 0건. 단, 예산 v3가 과거 검증 수치를 “72.5%가 실제로 위험했으므로”라고 써 2028 적중률로 읽힐 수 있음. 가평은 위험 요인이 입력에 없어 근거 없이 제안됨. 보건 v3가 장성·함평을 “주변”이라고 [추정] 없이 씀
v3 → v4	규칙 3개 추가(성능은 과거 검증, 지리 정보도 [추정], “중앙값과 비슷” 요인은 근거 제외). 입력에 ① 3곳의 SHAP 요인, ‘기타 비율’ 정의, 상위 20곳 소아과 수 추가. 출력에 “다른 부서와 판단이 갈리는 지점” 추가	v3 예산은 ②를 “유지”, v3 보육은 “통폐합·전환”으로 서로 다르게 봤는데, 각자 모르고 있음	숫자 오류 0건. 가평 근거(정원 충족률 64.1%) 사용. 부서 간 충돌과 조정안이 직접 나옴

LLM이 찾아낸 우리 쪽 문제: v1과 v2 예산 응답이 “김해 정원 충족률 65.8%(중앙 65.8%)인데 ‘낮음’”을 짚었다. 반올림 전 값이 중앙값보다 아주 조금 낮아 생긴 표시 문제였다. v4 입력부터는 차이가 작으면(비율 1%p, 그 외 3% 이내) “중앙값과 비슷”으로 표시했다(김해·대덕·남동).

관점별 최종 해석 비교 (v4)

세 관점 모두 ① 3곳(고성·함안·가평)을 최우선으로 보았고, 갈린 곳은 ② 예방 43곳과 ③ 구조적 공백 55곳 중 어느 쪽을 먼저 할지다.

항목	보육정책 담당자	보건소(소아진료) 담당자	예산 담당자
핵심 판단	상위권은 어린이집 과잉 + 아동 급감 → 폐원 방지보다 계획적 통폐합·전환	접근성 사업은 ‘현재 공백’ 축 기준. 위험순위를 소아과 감소 순위로 쓰면 안 됨	예산을 ① 우선분·② 예방분·③ 접근성분으로 나눔. 금액은 점수가 아니라 0~5세 인구·남은 시설 수로
① 3곳	거점 어린이집 지정, 운영비 보조	순회·원격 진료 즉시 도입	순회 진료 + 남은 어린이집 운영비 보전
② 43곳	통폐합·전환 지원(목포·부산 중구 우선)	야간·휴일 연계로 예방, 목포(소아과 2곳) 이탈 감시	소아과 1~2곳만 남은 곳(목포·부산 중구·밀양·문경) 유지 지원 우선
③ 55곳	운영비 보조로 최소 시설 유지	가장 급함. 영유아가 많은 영광(2,182명)·해남(1,303명)부터 상설 거점 시범	시군별 신설 대신 광역 거점·순회로 묶음

항목	보육정책 담당자	보건소(소아진료) 담당자	예산 담당자
더 필요한 자료	시설별 정원·현원·재무, 시설 간 거리	관외 진료 비율·이동시간, 병원급 소아과·달빛어린이병원 위치	인접 시군 소아과 이동시간, 기존 사업 단가·성과
다른 부서와 갈리는 지점	보건은 ③ 우선, 예산은 대상 축소를 원할 것 → ②는 상위만 시범 통폐합 후 1년 뒤 확대 여부 결정	보육·예산은 ② 투자를 원할 것 → ②는 보육, ③은 보건이 저비용 순회·원격으로 분담	보육·보건은 ③ 우선, 예산은 남아 있을 때 지키는 ②가 효율적이라 봄 → 예산 3분할

세 관점의 조정안을 합치면 '①은 공동 최우선, ②는 보육 주도의 재편 + 소아과 1~2곳 지역 유지, ③은 보건 주도의 광역 순회·원격'으로 모인다.

교차검증 결과

응답 10개의 수치·개수·목록 주장을 결과 파일과 코드로 대조했다. 틀린 숫자 2건과 근거 없는 문장은 팀 해석에서 뺐다.

주장	출처	대조 결과	처리
상위 20곳 중 17곳에서 '0~5세 1천명당 어린이집'이 1·2위 요인	v1, v2 예산	틀림. 18곳(사하구·부산 북구만 제외)	18곳으로 고쳐 사용
상위 20곳 중 18곳이 같은 요인	v2 보육	맞음	채택
상위 20곳 중 12곳이 부산·경남	v1	맞음(부산 5, 경남 7)	채택
①+③ = 58곳 = 소아과 0곳 시군구	v1, v3 보건	맞음	채택
아동 대비 시설은 오히려 늘었다	v1	맞음. 0~5세 1천명당 어린이집 15.3(2016) → 17.0(2025)	채택
목포 1천명당 소아과 0.44곳	v2 보건	맞음(2곳 ÷ 4,548명)	채택
1천명당 소아과 1곳 미만: 창원·광산·대전 동구·당진·서산·천안·거제	v2 보건	값은 맞음. 울산 동구(0.96)·대전 중구(0.98)·사천(0.75) 누락	전체 목록을 코드로 다시 뽑아 사용
② 중 소아과 1곳: 부산 중구·밀양·문경 / 2곳: 목포·인천 동구·남원·계룡·사천·화순	v2 보육·보건	맞음(9곳)	채택

주장	출처	대조 결과	처리
③ 중 0~5세 인구 최다는 영광(2,182명)	v3·v4 보건	맞음(2위 해남 1,303명)	채택
김해 충족률이 중앙값과 같은데 '낮음'	v1, v2 예산	맞음. 우리 표시 문제	v4 입력부터 '중앙값과 비슷' 표시
"72.5%가 실제로 위험했으므로"	v3 예산	과거(2021·2022) 검증값인데 2028 적중률처럼 읽힘	뺐. v4 규칙 6 추가
2027 본예산 의회 심의 단계, 지방소멸대응기금 활용	v2 예산	입력에 없는 외부 사실	팀 해석에서 뺐(필요하면 원출처 확인 후 사용)
영광 "주변" 장성·함평을 묶어 권역 운영	v3 보건	인접 여부는 입력에 없음	뺐. v4 규칙 7 추가
②는 "어린이집을 유지하는 예방 사업"	v3·v4 예산	상위 ② 지역은 1천명당 어린이집이 중앙값보다 높아(예: 목포 25.07, 동두천 31.81) '시설 유지'와 맞지 않음	'소아과 1~2곳 유지 + 어린이집 재편'으로 고쳐 사용
가평은 기타 비율 23.1% → 직장·법인 시설을 거점으로	v4 보육	수치는 맞음. 단, 해당 요인은 위험을 올린 요인이라 거점 근거로는 비약	'검토 후보'로만 남김

v4 세 응답의 수치 71개(중복 포함, 항목 번호 제외)는 모두 입력에 있는 값이었고, 지역·항목과의 연결도 하나씩 대조해 일치했다.

팀 최종 해석과 분석 반영 사항

검증을 통과한 문장만 모아 팀 해석으로 채택했다. 발표·기획서에는 이 다섯 줄을 쓴다.

1. 위험 상위권은 '아이는 빠르게 줄었는데 어린이집은 아직 많은 곳'이다. 상위 20곳 중 18곳에서 0~5세 1천명당 어린이집이 주요 요인이었다. 따라서 ② 예방 대상의 과제는 시설 수 유지가 아니라 공백 없는 재편(통폐합·전환, 거점 지정)이다.
2. ② 안에서도 소아과 의원이 1~2곳만 남은 9곳(목포·부산 중구·밀양·문경·인천 동구·남원·계룡·사천·화순)은 한 곳만 문을 닫아도 소아과 공백이 된다. 이곳은 소아과 유지 지원을 먼저 검토한다.
3. ③ 구조적 공백 55곳은 위험순위가 낮아도 '안전'이 아니다. 이미 소아과가 없어 더 줄 것이 없기 때문이며, 보건 주도의 광역 순회·원격 진료가 필요하다. 영유아가 많은 영광(2,182명)·해남(1,303명)부터 시작한다.
4. ① 최우선 3곳(고성·함안·가평)은 세 부서가 모두 최우선으로 봤다. 0~5세 529~1,326명 규모라 신설보다 거점 어린이집 + 순회 소아진료 묶음이 맞다.
5. 예산은 ① 우선분·② 재편분·③ 접근성분으로 나누고, 금액은 위험점수가 아니라 0~5세 인구와 남은 시설 수로 정한다. 점수는 순위용이며, 성능 수치는 과거 검증 결과다.

분석에 반영할 점 (LLM 지적 중 타당한 것)

- [ ] SHAP 요인 표시: 중앙값과 차이가 작으면 '중앙값과 비슷' (LLM 입력에 반영 완료)
- [ ] 같은 표시 규칙을 결과 엑셀·위험 지도의 위험 이유에도 적용
- [ ] 소규모 지역(부산 중구 0~5세 285명, 고성 529명)은 시설 1곳에도 비율이 크게 변함 → 한계에 명시
- [ ] 급감 고위험 기준(상위 46곳)을 15%·25%로 바꿔도 ① 목록이 유지되는지 민감도 확인
- [ ] 보건 관점 요청: 소아과 라벨만 따로 쓴 순위(현재 점수는 어린이집 요인이 주도)

부록: 프롬프트 틀과 최종(v4) 응답 원문

프롬프트 10개(입력 데이터 포함)와 응답 10개의 원문 전체는 별도 파일 LLM_해석_원문로그.md에 있다. 여기는 버전별 프롬프트 틀과 v4 응답만 싣는다. 보건·예산 프롬프트는 [역할] 문장과 5)번의 상대 부서 이름만 다르다.

역할 정의 (v3·v4)

관점	역할	하는 일	목표
보육	광역 시도 보육정책과 담당자	내년도 어린이집 지원사업(통폐합·전환 지원, 운영비 보조, 거점 어린이집 지정) 대상 후보 선정	폐원으로 생기는 보육 공백을 막고 남은 시설을 효율적으로 재편
보건	광역 시도 보건정책과 (소아의료) 담당자	소아 진료 접근성 개선사업(공공소아진료 연계, 순회·원격 진료, 달빛어린이병원 등 야간·휴일 진료 연계) 대상 선정	영유아가 사는 곳 가까이에서 진료
예산	광역 시도 예산 담당자	보육·소아의료 사업 간, 시군구 간 예산 배분과 근거 설명	같은 예산으로 공백을 가장 많이 막고, 근거를 설명 가능하게

v1 프롬프트

```
다음은 우리 팀의 공공데이터 분석 결과야. 이 결과를 해석해줘.

{입력 데이터 A}
```

v2 프롬프트 (보육)

```
너는 지자체 보육정책 담당자야. 아래 분석 결과를 보고 네 업무 관점에서 어떤 의미가 있는지, 무엇을 해야 하는지 해석해줘.

{입력 데이터 A}
```

v4 프롬프트 (보육) — v3는 이 중 규칙 5의 둘째 문장, 규칙 6·7, 출력 5)를 뺀 것이고 900자 제한이다.

```
[역할] 너는 광역 시도 보육정책과 담당자다. 지금 하는 일은 내년도 어린이집 지원사업(통폐합·전환 지원, 운영비 보조, 거점 어린이집 지정) 대상 시군구 후보를 고르는 일이다. 목표는 어린이집 폐원으로 생기는 보육 공백을 막고, 남은 시설을 효율적으로 재편하는 것이다.

[입력] 아래는 공공데이터로 만든 2028년 시군구 보육·소아의료 급감 위험 예측 결과다.

{입력 데이터 B}

[규칙]
1. 숫자와 지역명은 위 입력에 있는 것만 쓴다. 입력에 없는 숫자(예산액, 인구, 시설 수 등)를 만들지 않는다.
2. 입력에 없는 사실(지역의 산업 사정, 기존 정책, 감소 원인 등)을 말할 때는 문장 끝에 [추정]을 붙인다.
3. 위험점수는 순위용 점수다. "OO% 확률로 폐원" 같은 표현을 쓰지 않는다.
4. 유형 ①~④의 차이(급감 위험과 현재 공백은 다른 축)를 반영해 지역마다 다른 대응을 제안한다.
5. SHAP 요인은 '모델이 위험을 높게 본 이유'이지 인과관계가 아니다. 인과처럼 단정하지 않는다. "중앙값과 비슷"으로 표시된 요인은 근거로 쓰지 않는다.
6. 성능 수치(AUC, 72.5%)는 과거 검증 결과다. "2028년 상위 20곳 중 72.5%가 위험하다"처럼 쓰지 않는다.
7. 지역 간 인접·거리·생활권처럼 입력에 없는 지리 정보도 [추정]을 붙인다.

[출력 형식] 한국어, 1,000자 이내.
1) 내 업무 관점의 핵심 판단 3줄
2) 우선 검토할 지역 5곳 이내: 지역 / 유형 / 입력에 있는 근거 수치 / 제안 조치
3) 이 결과만으로는 판단할 수 없는 것 2가지
4) 결정 전에 추가로 확인할 자료 2가지
5) 보건소·예산 담당자와 판단이 갈릴 수 있는 지점 1가지와, 내 관점에서의 조정안
```

입력 데이터

- A(v1~v3): 2028 예측 요약(대상·위험 정의·모델 성능·유형별 수·전국 추세·전국 중앙값), 위험 상위 20곳과 SHAP 요인 3개, ①·②·③ 전체 지역 목록(0~5세 인구, 어린이집 수, 소아과 의원 수, 위험순위)
- B(v4): A + '기타 비율' 등 변수 정의, "성능 수치는 과거 검증 결과" 문장, 상위 20곳별 소아과 의원 수, ① 3곳의 SHAP 요인, 중앙값과 차이가 작은 요인의 '중앙값과 비슷' 표시

v4 응답 원문 — 보육정책 담당자

```
**1) 핵심 판단**
- 상위 20곳은 대부분 어린이집이 많은데 아동은 빠르게 줄고 있는 지역입니다. 그래서 폐원을 막기보다 계획적으로 통폐합하고 전환하는 쪽이 맞습니다.
- ① 3곳은 급감 위험이 높고 소아과도 없습니다. 거점 어린이집 지정을 가장 먼저 검토합니다.
- ③ 55곳은 위험순위는 낮지만 이미 소아과가 없습니다. 운영비 보조로 최소한의 시설을 유지하는 별도 사업으로 다룹니다.
```

```
**2) 우선 검토 지역**
| 지역 | 유형 | 근거 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 경남 고성군 | ① | 0~5세 529명, 어린이집 11곳, 3년 변화율 -37.5% | 거점 어린이집 지정, 운영비 보조 |
| 경남 함안군 | ① | 1천명당 어린이집 30.37곳, 0~5세 대비 정원 1.20 | 정원 줄이는 통폐합, 거점 1곳 지정 |
| 경기 가평군 | ① | 정원 충족률 64.1%, 기타 비율 23.1% | 직장·법인 시설 활용해 거점 지정 검토 |
| 부산 중구 | ② | 0~5세 285명, 1천명당 어린이집 35.09곳, 소아과 1곳 | 통폐합하되 거점 유지, 공백 생기는지 감시 |
| 전남 목포시 | ② (1위) | 어린이집 1년 변화율 -13.0%, 1천명당 25.07곳 | 통폐합·전환 지원 (폐원보다 전환 유도) |

**3) 이 결과만으로 판단할 수 없는 것**
- 어느 시설이 언제 문을 닫을지 (시설 단위 정보가 없음)
- 2028년 예측이 얼마나 맞을지 (성능 수치는 과거 검증 결과일 뿐임)

**4) 추가로 확인할 자료**
- 시설별 정원·현원·재무 현황
- 시설 간 거리와 생활권 자료 (거점 시설이 실제로 접근 가능한지 확인용)

**5) 판단이 갈릴 수 있는 지점과 조정안**
- **갈리는 지점:** 보건소는 소아과가 없는 ③ 55곳을 우선하자고 할 수 있습니다 [추정]. 예산 담당은 대상 지역 수를 줄이자고 할 수 있습니다 [추정].
- **조정안:**
  - ① 3곳은 공동 최우선으로 둡니다.
  - ③은 보건소 소아의료 사업과 함께 운영비만 지원합니다.
  - ②는 상위 순위 지역만 시범 통폐합하고, 1년 뒤 실제 감소 결과를 보고 확대 여부를 정합니다.
```

v4 응답 원문 — 보건소 담당자

```
1) 핵심 판단
- 급감 위험과 진료 공백은 서로 다른 축입니다. 접근성 사업의 1순위는 소아과 의원이 0곳인 ① 3곳과 ③ 55곳입니다.
- 상위 20곳의 위험 요인은 대부분 어린이집 관련 변수입니다. 소아과와 관련된 요인은 창원시(0~5세 1천명당 0.84곳)와 광주 광산구(시도 폐업률 24.4%) 정도입니다. 그래서 위험순위를 소아과가 줄어들 순위로 쓰면 안 됩니다.
- ②에는 지금 의원이 있어 당장 공백은 아닙니다. 그래서 야간·휴일 진료 연계로 공백을 막는 예방형 사업이 맞습니다.

2) 우선 검토 지역
- 경남 고성군 / ① / 0~5세 529명, 소아과 0곳, 3년 변화율 -37.5%, 위험순위 17 / 순회진료와 원격진료를 바로 도입
- 경남 함안군 / ① / 0~5세 889명, 소아과 0곳, 3년 변화율 -36.7%, 위험순위 19 / 공공 소아
```

진료 연계, 가까운 시의 야간 진료기관 연계[추정]
- 경기 가평군 / ① / 0~5세 1,326명, 소아과 0곳, 위험순위 30 / 순회진료를 정기적으로 운영
- 전남 영광군·해남군 / ③ / 0~5세 2,182명·1,303명, 소아과 0곳 / 급감 위험은 낮아도 공백이 계속되므로 상설 원격·순회 거점을 시범 운영
- 전남 목포시 / ② / 0~5세 4,548명에 소아과 2곳, 위험순위 1 / 의원이 빠져나가는지 지켜보고 달빛어린이병원 연계 점검

3) 이 결과만으로 판단할 수 없는 것
- 실제 접근성: 행정구역 안의 의원 수만 있어서 옆 시군구 이용이나 이동시간을 알 수 없습니다.
- 의원 말고 다른 진료 자원: 병원급 소아청소년과나 보건소 진료가 있는지 알 수 없습니다.

4) 추가로 확인할 자료
- 시군구별 영유아의 관외 진료 비율과 의료기관까지 이동시간
- 병원급 소아청소년과, 달빛어린이병원, 응급실의 위치와 운영시간

5) 판단이 갈릴 수 있는 지점과 조정안
보육·예산 쪽은 위험순위가 높고 영유아가 많은 ② 43곳에 먼저 투자하자고 할 수 있습니다. 보건 쪽에서는 지금 소아과가 없는 ③ 55곳이 더 급합니다.
조정안은 다음과 같습니다.
- ①은 두 부서가 함께 최우선으로 지원합니다.
- ②는 보육 쪽 예방사업이 중심이 됩니다.
- ③은 보건 쪽이 비용이 적게 드는 순회·원격 모델로 맡고, 영유아가 많은 곳부터 단계적으로 넓힙니다.
- 성능 수치(AUC 0.79)는 과거 자료로 검증한 값입니다. 그래서 매년 실제 변화와 비교해 대상을 다시 검토한다는 조건을 붙입니다.

v4 응답 원문 — 예산 담당자

1) 핵심 판단
- 유형별로 예산 항목을 나눕니다. ②(43곳)는 아직 남아 있는 시설을 유지하는 예방 예산, ③(55곳)은 이미 비어 있는 곳의 접근성을 확보하는 예산, ①(3곳)은 두 가지를 함께 지원하는 대상입니다.
- 위험점수는 순위를 매기는 용도일 뿐입니다. 그래서 금액 규모는 점수가 아니라 0~5세 인구와 현재 남아 있는 시설 수로 정합니다.
- ① 3곳은 0~5세 인구가 529~1,326명으로 적습니다. 따라서 시설을 새로 짓기보다 순회 진료나 인근 연계 같은 방식이 현실적일 수 있습니다. [추정]

2) 우선 검토 지역
- **경남 고성군 / ①**: 0~5세 529명, 어린이집 11곳, 소아과 0곳, 3년 변화율 -37.5%입니다. 순회 소아진료를 운영하고 남은 어린이집의 운영비를 보전하는 방안을 제안합니다.
- **경남 함안군 / ①**: 1천명당 어린이집 30.37곳, 0~5세 대비 정원 1.20, 소아과 0곳입니다. 보육은 정원 조정과 기능 전환을 검토하고, 소아의료는 접근 수단을 확보하는 방안을 제안합니다.
- **경기 가평군 / ①**: 0~5세 1,326명, 소아과 0곳, 정원 충족률 64.1%입니다. 소아진료 연계를 우선하고, 보육 쪽은 우선 관찰하는 방안을 제안합니다.
- **전남 목포시 / ②**: 위험순위 1위, 소아과 2곳, 3년 변화율 -31.8%, 어린이집 1년 변화율 -13.0%입니다. 남아 있는 소아과 2곳의 유지를 지원하고 어린이집을 거점 중심으로 재편하는 방안을

제안합니다.
- **부산 중구 / ②**: 0~5세 285명, 소아과 1곳, 3년 변화율 -40.7%입니다. 소아과 1곳이 문을 닫으면 바로 공백이 생기므로 유지 지원을 우선 검토합니다.

3) 이 결과만으로는 판단할 수 없는 것
- 2028년에 실제로 얼마나 줄어들지는 알 수 없습니다. 점수는 확률이 아니고, 성능 수치도 과거 자료로 검증한 결과입니다.
- 어떤 지원 수단이 공백을 막는 데 효과가 있는지도 알 수 없습니다. SHAP 요인은 모델이 위험을 높게 본 이유일 뿐 원인이 아닙니다.

4) 추가로 확인할 자료
- 인접 시군구 소아과까지의 이동 거리와 시간. 생활권 공유 여부를 확인해야 합니다. [추정]
- 기존 보육·소아의료 지원사업의 단가, 집행 실적, 효과 자료

5) 판단이 갈리는 지점과 조정안
- **갈리는 지점**: 보육·보건 담당자는 이미 공백인 ③ 55곳을 먼저 지원하자고 할 수 있습니다. 반면 예산 관점에서는 시설이 남아 있을 때 지키는 ②가 같은 예산으로 공백을 더 많이 막을 수 있다고 봅니다. [추정]
- **조정안**: 예산을 ① 우선 확보분, ② 예방분, ③ 접근성분으로 나눠 구분해서 편성합니다.
  - ③은 시군구마다 시설을 새로 짓는 대신 광역 거점과 순회 방식으로 묶습니다. [추정]
  - ② 안에서는 소아과가 1~2곳만 남은 곳을 먼저 지원합니다. 목포시, 부산 중구, 밀양시, 문경시 등이 해당합니다.